研修医向け

長寿＝健康ではない ―
データで考える在宅医療の意義

参考文献

2026-03-29 ・ AI(Claude)作成・主な出典は原典で確認

問い: なぜ日本人は長生きなのか？

あなたの答えを一つ、頭の中に思い浮かべてください

- 食事？ 遺伝？ 医療制度？ 運動習慣？
- **今日のデータは、その常識を問い直すかもしれません**

この勉強会のゴール

この15分の後、あなたは:

1. 日瑞比較研究の主要データを**説明**できる（理解）
2. 「長寿＝健康な国民」という仮説を**批判的に吟味**できる（分析）
3. 在宅医療の意義を国際比較データで**語る準備**ができる（創造）

前提知識の確認

健康寿命と平均寿命

- **平均寿命**: 0歳時点の平均余命
- **健康寿命**: 日常生活に制限なく生活できる期間
- 日本(2022年): 男性 81.05歳(健康寿命 72.57歳)、女性 87.09歳(健康寿命 75.45歳)。健康寿命は2022年値が最新(令和8年版高齢社会白書)。平均寿命は2025年で男性 81.35歳・女性 87.33歳(令和7年簡易生命表)
- **ギャップ = 不健康な期間**: 男性 約8.5年、女性 約11.6年

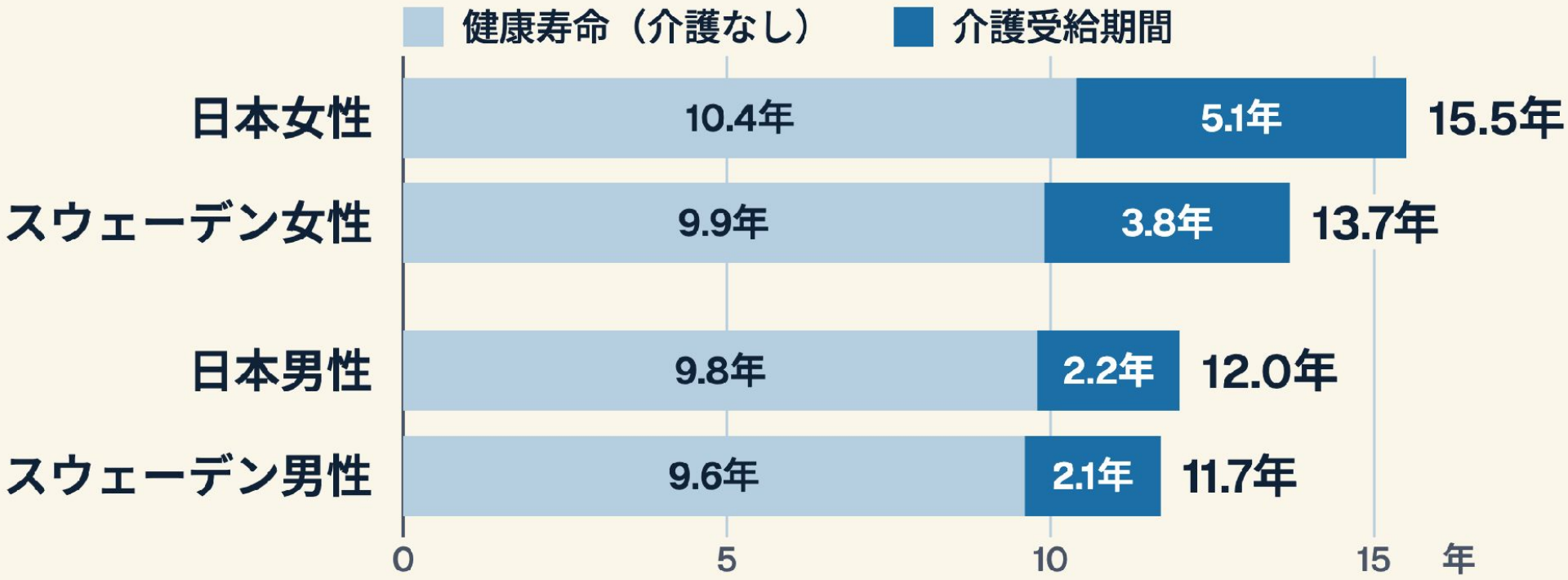
  この「ギャップ」の期間に何が起きているかが、今日の論文の焦点です

研究の概要

Understanding Japan’s mortality advantage（BMC Medicine, 2026.3.23）

- **研究チーム**: カロリンスカ研究所 Karin Modig ら（九州大学・神戸大学と共同）
- **筆頭著者**: Shunsuke Murata
- **デザイン**: 観察研究（レジストリデータに基づく人口ベースの比較。スウェーデンは全国、日本は9自治体）
- **対象**: 75歳以上 — 日本9自治体（33万人超）vs スウェーデン（85万人超）
- **分析手法**: 75歳時の残余余命を「介護なし期間」と「介護受給期間」に分解

核心データ



健康寿命はほぼ同等。差が生まれているのは「介護を受けている期間」

75歳時の残余余命・棒の右端は合計。出典: Murata S, Modig K, et al. BMC Medicine 2026;24:160

核心的発見

日本の平均寿命の優位性は「介護受給者の低死亡率」に起因する

- 介護を受けずに暮らせる年数（健康寿命）は日瑞で**ほぼ差がない**
- 日本の女性の優位（+1.8年）の大部分は、介護受給期間の長さ（5.1年 vs 3.8年。合計余命から介護なし期間を引いた値）
- これは介護受給者の**死亡率が日本で低い**ことを意味する

Karin Modig: ”Perhaps Japan’s long life expectancy is not primarily due to the population being healthier”

批判的吟味のポイント

Strengths

- 全人口レジストリデータ（選択バイアスが小さい）
- 75歳以上に限定し、比較可能性を高めている
- 査読を経た原著論文（BMC Medicine）。雑誌の格は個々の研究の妥当性を保証しない

Limitations

- 「介護認定」の定義が日瑞で異なる（日本: 介護保険の認定、スウェーデン: コミューン判定）
- 日本は9自治体のみ（全国代表性の限界）
- 死亡率の「なぜ」（メカニズム）は未解明
- 両国の健康状態の違いを調整できておらず、介護に入る基準が両国で異なる可能性がある（著者も言及）
- 交絡因子（終末期医療の積極性、家族構成、文化的要因）の調整が不十分な可能性

なぜ日本の介護受給者は死亡率が低いのか？

考えられる要因（論文の考察 + Analyst見立て）

1. **在宅医療の充実**: 訪問診療・訪問看護の体制（日本のユニークさ）
2. **家族介護の文化**:「家族介護 + 公的サービス」のハイブリッドモデル
3. **終末期医療の積極性**: 日本は積極的医療介入の傾向がスウェーデンより強い
4. **介護保険制度**: 2000年導入、要介護・要支援の認定を受けた65歳以上は令和5年度で695.2万人（令和8年版高齢社会白書）

   対比: スウェーデンはCOVID-19の第1波（2020年）に介護を受ける高齢者の死亡が多かった。2020年5月下旬の時点で、死亡者の約90%が70歳以上（同国公衆衛生庁の発表、The Local 2020-05-25）

ペアディスカッション（4分）

問い1（2分）

あなたが担当している在宅患者さんを1人思い浮かべてください。
その方のケアのどの部分が「死亡率を下げる」ことに貢献していると思いますか？

問い2（2分）

この研究の「介護受給者の死亡率が低い」という知見は、
在宅医療の価値を患者・家族にどう説明するときに使えますか？

ディスカッション共有

期待される視点

- 訪問診療による早期介入（急変の早期発見）
- 多職種連携（医師・看護師・介護士・ケアマネ）のシステム効果
- 家族を含めたケアチームの存在
- 「関係性のネットワーク」としてのケアシステム（システム思考の視点）

倫理的問い

- 終末期の積極的医療介入が寿命延伸に寄与しているとすれば、それは**常に望ましいのか？**
- QOL（Quality of Life）とQOD（Quality of Death）のバランスは？

振り返り

今日の3つのKey Takeaway

1. 日本の長寿は「健康な国民」ではなく「ケアシステムの力」が主因かもしれない
2. 健康寿命は日瑞でほぼ同等 — 差は「介護受給者の死亡率」にある
3. あなたが関わる在宅ケアの一つ一つが、日本の長寿統計を支えている

まとめ

持ち帰りの問い

明日の訪問診療で:「この患者さんのケアが、国際比較データの中の1データポイントである」と意識したとき、何が変わりますか？

さらに深めたい方へ

- 原著論文: BMC Medicine 2026 (https://link.springer.com/article/10.1186/s12916-026-04786-z)
- カロリンスカ研究所プレスリリース: Swedish study adds nuances (https://news.ki.se/swedish-study-adds-nuances-to-the-picture-of-healthy-japanese-ageing)
- 関連: 昨日のDeep Dive「緩和ケアの早期統合」との接続を考えてみてください

出典

1. Murata S, Modig K, et al. Understanding Japan’s mortality advantage: a comparison of mortality in independent and dependent older adults in Japan and Sweden. BMC Medicine. 2026;24:160. doi:10.1186/s12916-026-04786-z
2. OECD. Health at a Glance 2025: Japan. 2025.
3. 内閣府. 令和8年版高齢社会白書. 2026.
4. Tsutsui T. Implementation process and challenges for the community-based integrated care system in Japan. Int J Integr Care. 2014;14:e002.

参考文献